HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

INSTITUT NATIONAL DU CANCER

ACTES ET PRESTATIONS - AFFECTION DE LONGUE DURÉE

Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique

Lymphomes non hodgkiniens de l'adulte

Les Parcours de Soins

Janvier 2015

Ce document est téléchargeable sur :

www.has-sante.fr et sur www.e-cancer.fr

Haute Autorité de Santé

Service des maladies chroniques et dispositifs d'accompagnement des malades

2, avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine Cedex

Tél. : +33 (0)1 55 93 70 00 – Fax : +33 (0)1 55 93 74 00

Institut National du Cancer

Département Diffusion des bonnes pratiques et information des malades

52, avenue André Morizet - 92513 Boulogne-Billancourt Cedex

Tél. : +33 (0)1 41 10 50 00 – Fax : +33 (0)1 41 10 50 20

Ce document a été validé par le Collège de la Haute Autorité de Santé en 2015.
© Haute Autorité de Santé – 2015

Sommaire

1. Avertissement 4

2. Critères médicaux d'admission en vigueur (Décret n° 2011-74-75-77 du 19 janvier 2011 et n°2011-726 du 24 juin 2011) 6

3. Professionnels de santé impliqués dans le parcours de soins 7

4. Biologie - Anatomopathologie 9

5. Actes techniques 11

6. Traitements 12
   - 6.1 Traitements pharmacologiques 12
   - 6.2 Autres traitements 14
   - 6.3 Dispositifs médicaux, aliments diététiques destinés à des fins médicales spécialisées et appareils divers d'aide à la vie 14

7. Annexe 15

Mise à jour des actes et prestations ALD (APALD)

Les actes et prestations ALD (APALD) sont actualisés une fois par an et disponibles sur le site internet de la HAS (www.has-sante.fr) et celui de l'INCa (www.e-cancer.fr)

1. Avertissement

Contexte Affection de longue durée (ALD)

Les ALD sont des affections nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (article L.324-1)

Depuis la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'Assurance Maladie, l'exonération du ticket modérateur pour l'assuré est soumise à l'admission en ALD à l'aide d'un protocole de soins établi de façon conjointe entre le médecin traitant et le médecin-conseil de la sécurité sociale, signé par le patient.

Missions de la HAS en matière d'ALD

Conformément à ses missions,((article L 161-37-1 et art. R. 161-71 3), la Haute Autorité de santé formule des recommandations sur les actes et prestations nécessités par le traitement des affections mentionnées à l'article L.324-1 pour lesquelles la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application du 3° et 4° de l'article L.322-3 :

Par *ailleurs, elle :*

- *émet un avis sur les projets de décret pris en application du 3° de l'article L. 322-3 fixant la liste des affections de longue durée ;*
- *formule des recommandations sur les critères médicaux utilisés pour la définition de ces mêmes affections ;*
- *formule des recommandations sur les actes médicaux et examens biologiques que requiert le suivi des affections relevant du 10° de l'article L.322-3.*

Élaboration HAS/INCa des guides ALD 30 Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique

La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a créé l'Institut National du Cancer.

L'Institut est chargé de coordonner les actions de lutte contre le cancer. À ce titre, il a notamment pour missions : la « définition de référentiels de bonnes pratiques et de prise en charge en cancérologie », l'« information des professionnels et du public sur l'ensemble des problèmes relatifs au cancer » et le « développement et suivi d'actions communes entre opérateurs publics et privés en cancérologie dans les domaines de la prévention, de l'épidémiologie, du dépistage, de la recherche, de l'enseignement, des soins et de l'évaluation ».

Ainsi dans le cadre de l'élaboration des guides de l'ALD 30 *Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique*, l'Institut National du Cancer apporte son expertise et définit le contenu médical du guide ALD selon la méthodologie définie par la Haute Autorité de Santé et sous son pilotage.

Objectif du document actes et prestations ALD

Le document actes et prestations ALD est une **aide à l'élaboration du protocole de soins établi pour l'admission en ALD** d'un patient, ou son renouvellement. Il est proposé comme **élément de référence pour faciliter le dialogue entre le malade, le médecin traitant et le médecin conseil.**

Ce n'est ni un outil d'aide à la décision clinique, ni un résumé du guide médecin.

Contenu du document actes et prestations ALD

Ce document **comporte les actes et prestations nécessités par le traitement de l'affection, pris en charge par l'assurance maladie obligatoire, selon les règles de droit commun ou des mesures dérogatoires**. Ainsi les utilisations hors AMM ou hors LPPR n'y seront inscrites qu'en cas de financement possible par un dispositif dérogatoire en vigueur. Il faut noter que les prescriptions hors AMM, y compris dans ces dispositifs dérogatoires, sont assorties de conditions notamment une information spécifique du patient.

Le document actes et prestations n'a pas de caractère limitatif. Le guide peut comporter des actes ou prestations recommandés mais ne bénéficiant pas d'une prise en charge financière. Aussi **l'adaptation du protocole de soins à la situation de chaque patient relève du dialogue entre le malade, le médecin traitant et le médecin conseil de l'assurance maladie.**

2. Critères médicaux d'admission en vigueur (Décret n° 2011-74-75-77 du 19 janvier 2011 et n°2011-726 du 24 juin 2011)

ALD 30 « Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique »

Relèvent d'une exonération du ticket modérateur les affections malignes caractérisées par :

- des arguments objectifs indiscutables : histologie, perturbations hématologiques ou humorales caractéristiques ;
- ou, en l'absence de preuve directe, un faisceau d'arguments cliniques, radiologiques ou biologiques convergents et emportant la décision médicale.

L'exonération initiale est accordée pour une durée de 5 ans, renouvelable dès lors que la poursuite d'une thérapeutique ou la prise en charge diagnostique et thérapeutique des séquelles liées à la maladie ou aux traitements, notamment l'usage permanent d'appareillages, sont nécessaires.

Toute récidive ou apparition d'une séquelle tardive grave dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.

3. Professionnels de santé impliqués dans le parcours de soins

Bilan initial	
Professionnels	**Situations particulières**
Médecin généraliste	Tous les patients. Devant une adénopathie persistante d'origine inconnue après élimination d'une cause locale ou infectieuse, il importe d'adresser le patient à l'hématologue ou en milieu oncologique spécialisé pour une biopsie-exérèse et sauf urgence compressive, d'éviter formellement toute corticothérapie avant celle-ci
Onco-hématologue	Tous les patients, dès le stade de suspicion d'un lymphome, pour organisation de l'analyse histologique d'une biopsie du site atteint
Chirurgien	Tous les patients. La biopsie ganglionnaire est l'examen de référence pour porter le diagnostic de lymphome. La biopsie-exérèse chirurgicale totale mais non élargie (pas de curage ganglionnaire) permet l'analyse architecturale du ganglion. Elle est recommandée mais alternativement, il peut s'agir d'une biopsie à l'aiguille guidée par examen radiologique (échographie ou scanner)
Anesthésiste	Tous les patients avant acte chirurgical
Biologiste	Tous les patients pour bilan initial et pré-thérapeutique
Radiologue	Tous les patients. L'imagerie est essentielle pour déterminer le stade du lymphome
Médecin de médecine nucléaire	Tomoscintigraphie par émission de positons ou TEP-scanner au fluorodésoxyglucose (18F-FDG) pour tous les patients atteints de lymphome sauf lymphome de la zone marginale et lymphome lymphocytique (évaluation en cours)
Anatomopathologiste	Tous les patients. Le diagnostic de LNH repose sur l'analyse histologique d'une biopsie du site atteint. Le compte-rendu anatomopathologique doit se référer à l'actuelle classification internationales OMS 2008 des hémopathies malignes et une 2de lecture par un pathologiste spécialisé doit être envisagée (réseau national de référence LYMPHOPATH)
Recours selon besoin	
Cytogénéticien	Selon besoin
Oncologue radiothérapeute	En cas d'indication de radiothérapie
Gériatre	Évaluation gériatrique
Autres spécialistes	Selon besoin en fonction notamment des formes (localisations) ou complications de la maladie

Traitement et suivi	
Professionnels	**Situations particulières**
Médecin généraliste	Tous les patients. En articulation avec l'équipe spécialisée, suivi et prise en charge ambulatoires des effets indésirables et complications, tant aigus et précoces que tardifs, interventions en soins de support et soins palliatifs à domicile, suivi partagé dans l'après-cancer Après 5 ans, le suivi des complications (cardiaques, endocriniennes, etc.) peut être assuré par le médecin généraliste et les spécialistes d'organe concernés
Onco-hématologue	Tous les patients, prise en charge en équipe spécialisée en articulation avec le médecin traitant et les autres professionnels de proximité. Elaboration d'un programme personnalisé de soins (PPS) après réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP), en accord avec le patient et si possible en concertation avec le médecin traitant
Radiologue	Tous les patients, imagerie comparative avec celle du bilan initial permettant d'ajuster précocement le traitement puis ultérieurement, avec une fréquence à adapter selon le stade, le type de LNH, l'histologie et les facteurs de risque.
Biologiste	Tous les patients, surveillance habituellement au même rythme que la surveillance clinique
Recours selon besoin	
Anatomopathologiste	En cas de récidive
Oncologue radiothérapeute	En cas d'indication de radiothérapie
Gériatre	Suivi gériatrique
Autres spécialistes	Selon besoin, en fonction notamment des complications, séquelles ou formes (localisations) de la maladie
Dentiste	Selon besoin
Infirmier	Selon besoin
Kinésithérapeute	Selon besoin, notamment soins palliatifs
Diététicien	Selon besoin pour les patients dénutris Prestation dont le remboursement n'est pas prévu par la législation (*prise en charge possible dans le cadre de structures hospitalières ou d'un réseau*)
Autres intervenants potentiels	
Psychologue	Selon besoin Prestation dont le remboursement n'est pas prévu par la législation *(prise en charge possible dans le cadre de structures hospitalières ou d'un réseau)*

4. Biologie - Anatomopathologie

Actes	Situations particulières
Systématiques	
Hémogramme	Tous les patients – Bilan initial et suivi
Ionogramme	Tous les patients – Bilan initial et suivi
Uricémie, calcémie, phosphorémie	Selon besoin, bilan initial et suivi
VS, CRP	Tous les patients – Bilan initial et suivi
Électrophorèse des protéines	Tous les patients – Bilan initial et suivi
Immuno-électrophorèse ou immunofixation	En complément de l'électrophorèse des protéines en cas d'anomalie de celle-ci
Créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire	Tous les patients – Bilan initial et suivi
Bilan hépatique (transaminases, phosphatases alcalines , bilirubine directe et indirecte, gamma-glutamyl transférases)	Tous les patients – Bilan initial et suivi
Lactate déshydrogénase (LDH)	Tous les patients – Bilan initial et suivi
Sérologies des virus de l'hépatite B et C (VHB et VHC)	Tous les patients – Bilan initial et suivi post-transfusionnel
Sérologie du virus de l'immunodéficience humaine (VIH)	Recherche d'un terrain favorisant et suivi post-transfusionnel
Dosage de bêta-hCG	Dépistage de grossesse avant et sous traitement pour toutes les patientes en âge de procréer
Actes d'anatomie et de cytologie pathologiques	Tous les patients – Bilan initial et récidives
Examen cytologique et biochimique du liquide céphalo-rachidien (LCR)	Recherche d'une atteinte méningée systématique pour les LNH agressifs Pour le traitement intrathécal s'il existe une atteinte neuroméningée
Gazométrie artérielle	Selon besoin en cas d'antécédents respiratoires
Marqueurs tumoraux	Aucun dosage de marqueurs tumoraux n'est recommandé
Examens à faire selon les cas	
Frottis sanguin ou médullaire	En cas d'hyperleucocytose
Taux sérique de ß2-microglobuline	Tous les patients porteurs d'un lymphome folliculaire – Bilan initial et suivi
Charge virale Epstein Barr Virus (EBV)	Selon besoin – Bilan initial
Sérologies Virus T-lymphotropiques humains (HTLV1 et HTLV2)	Selon besoin – Lymphomes T, bilan initial
Sérologie *Helicobacter pylori*	Lymphomes gastriques, surtout si histologie négative pour la bactérie
Dosage de la thyréostimuline (TSH)	Recherche d'hypothyroïdie iatrogène en cas d'irradiation cervicale, une ou deux fois par an

Actes	Situations particulières
Caryotype des cellules tumorales	Dans certaines formes (lymphome du manteau, lymphome de Burkitt)
Dosage des immunoglobulines	Selon besoin
Analyses cytochimiques, immunophéno-type, analyses de biologie moléculaire	En milieu hospitalier - Tous les patients – Bilan initial
Autres examens	Selon signes d'appel ou traitements reçus

5. Actes techniques

Actes	Situations particulières
Systématiques	
Biopsie du site atteint avec actes d'anatomo-pathologie	Tous les patients – Bilan initial et suivi selon besoin
Tomodensitométrie cervico- thoraco-abdomino-pelvienne (scanographie des systèmes immunitaire et hématopoïétique) avec mesure des lésions tumorales cibles	Bilan initial servant de référence pour l'évaluation de la réponse au traitement Pour le suivi, recommandée pour la détection de récidives. Elle peut être réalisée à 6 mois puis à 1 an. Sa fréquence est à adapter en fonction du stade, des facteurs de risque, du type de lymphome et de l'histologie, en tenant compte du risque d'irradiation cumulée, notamment chez les patients les plus jeunes
TEP-scanner au fluorodésoxyglucose (18F-FDG)	Bilan initial pour tous les lymphomes sauf lymphome de la zone marginale et lymphome lymphocytique (évaluation en cours)
Examens à faire selon les cas	
Radiographies du thorax	Selon indications, peuvent être proposées comme alternative à la tomodensitométrie - Bilan initial et suivi
Échographie abdomino-pelvienne	Selon indications, peut être proposée comme alternative à la tomodensitométrie – Bilan initial et suivi
Biopsie médullaire unilatérale, habituellement complétée par myélogramme et aspiration médullaire	Selon indications
Cytoponction à l'aiguille fine	Alternative possible à la biopsie ganglionnaire dans un contexte d'urgence, en milieu spécialisé
ECG et exploration de la fonction ventriculaire gauche échographique ou isotopique	Évaluation de la fonction cardiaque pré-thérapeutique et suivi des traitements par anthracyclines
Remnographie [IRM], avec ou sans injection intraveineuse de produit de contraste	Selon indications, peut être utilisée dans certaines localisations osseuses rachidiennes et du système nerveux central en particulier.
Endoscopie ORL, bronchique, digestive ou urologique	En présence de signes d'appel ORL, bronchiques, digestifs ou urologiques
Épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR)	Antécédents de troubles respiratoires, selon besoin
Panoramique dentaire	Recherche d'un foyer dentaire
Ponction lombaire	Recherche d'une atteinte méningée systématique pour certains LNH agressifs Pour le traitement intrathécal s'il existe une atteinte neuroméningée
Cryoconservation de sperme	Selon besoin

6. Traitements

6.1 Traitements pharmacologiques

Traitements[1]	Situations particulières
Traitements spécifiques par agents antinéoplasiques et immunomodulateurs[2]	
Chimiothérapies par voie générale ou locale	Selon indications et AMM des produits utilisés
Anticorps monoclonaux mabthera	AMM pour le traitement de patients adultes porteurs d'un lymphome non hodgkinien (LNH) dans les indications suivantes : - en monothérapie pour le traitement des patients atteints de lymphomes folliculaires de stade III-IV en cas de chimiorésistance ou à partir de la deuxième rechute après chimiothérapie - en association à une chimiothérapie pour le traitement des patients présentant un lymphome folliculaire de stade III-IV n'ayant jamais été précédemment traités - en association à une chimiothérapie "CHOP" (cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine, prednisolone) pour le traitement des patients présentant un lymphome non-hodgkinien agressif diffus à grandes cellules B, CD20 positif. - en traitement d'entretien chez les patients présentant un lymphome folliculaire répondant à une immuno-chimiothérapie d'induction. *Prescription hospitalière réservée aux spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie*
Interféron alpha	Selon indications
Traitements symptomatiques	
Antiémétiques	Complications de la chimiothérapie
Antidiarrhéiques	Complications de la chimiothérapie
Antibiotiques	Complications de la chimiothérapie
Antiviraux	
Antifongiques	Complications de la chimiothérapie
Bains de bouche à base de chlorhexidine et préparations oncolo-	Traitement local d'appoint des infections de la cavité buccale

[1] Les guides mentionnent généralement une classe thérapeutique. Le prescripteur doit s'assurer que les médicaments prescrits appartenant à cette classe disposent d'une indication validée par une autorisation de mise sur le marché (AMM).

[2] *cf. également Annexe*

Traitements[1]	Situations particulières
giques en bain de bouche (associations d'antifongiques, de bicarbonate de sodium et de bain de bouche remboursable)	
Hypouricémiants	Hyperuricémie symptomatique primaire ou secondaire
Bisphosphonates (acide pamidronique, acide zolédronique, acide clodronique)	Ostéolyse ou hypercalcémie malignes
Facteurs de croissance granulocytaire et érythrocytaire[3]	Mobilisation de cellules souches périphériques. En fonction de la chimiothérapie, des facteurs de risque, des antécédents du patient et de son espérance de vie
Transfusions de culots globulaires et de plaquettes	Selon besoin
Corticoïdes	Selon besoin
Antihistaminiques	Prévention de chimiothérapie allergisante
Antalgiques de paliers 1 à 3	Adaptation selon l'intensité des douleurs
Antidépresseurs : imipramine amitriptyline	 Douleurs neuropathiques et algies rebelles Douleurs neuropathiques périphériques
Antiépileptiques : gabapentine prégabaline	 Douleurs neuropathiques périphériques Douleurs neuropathiques centrales et périphériques
Topiques anesthésiants	Selon besoin
Contraceptifs hormonaux	Contraception pendant la chimiothérapie et les 12 mois suivants Retrait d'un éventuel stérilet pour éviter le risque de saignements et d'endométrite Durant cette période, les rapports sexuels doivent être protégés afin d'éviter le passage de chimiothérapie toxique et de prévenir les infections sexuellement transmissibles
Laxatifs Bromure de méthylnaltrexone	Selon besoin, notamment sous traitement opioïde, ou à visée palliative Prise en charge de la constipation liée aux opioïdes chez les patients présentant une pathologie à un stade avancé et relevant de soins palliatifs, lorsque la réponse aux laxatifs habituels a été insuffisante
Émulsions à base de trolamine	Traitement de l'érythrodermie post-radiothérapie en précisant le cadre légal dérogatoire de la prise en charge (*prise en charge dérogatoire dans le cadre de l'article L.162-17-2-1 selon les modalités de l'arrêté du 1er avril 2010*)
Solutions pour nutrition parentérale	Lorsque l'alimentation orale ou entérale est impossible, insuffisante ou contre-indiquée

[3] Les recommandations concernant l'utilisation des facteurs de croissance en cancérologie émanant de trois sociétés savantes ont été actualisées en 2005 (*National Comprehensive Cancer Network*, NCCN) et en 2006 (*European Organisation for Research and Treatment of Cancer*, EORTC, et *American Society of Clinical Oncology Practice*, ASCO).
EORTC *guidelines for the use of granulocyte-colony stimulating factor to reduce the incidence of chemotherapy-induced febrile neutropenia in adult patients with lymphomas and solid tumours*. 2006; 42:2433–2453.

ASCO: Smith Thomas J. and al. 2006 Update of Recommendations for the Use of White Blood Cell Growth Factors: An Evidence-Based Clinical Practice Guideline*. ASCO 2006; 24, number 19.*

6.2 Autres traitements

Traitements	Situations particulières
Abstention thérapeutique avec surveillance régulière	Formes asymptomatiques indolentes de LNH à faible masse tumorale
Radiothérapie	Selon indications
Radio-immunothérapie	Selon indications, pour les lymphomes folliculaires en traitement des rechutes après traitement par le rituximab.
Greffe de cellules souches hématopoïétiques	Selon indications
Éducation thérapeutique	L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours du patient. Les professionnels de santé en évaluent le besoin avec le patient. Elle n'est pas opposable au malade, et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie (Art. L. 1161-1 du Code de la santé publique)[4] *Prise en charge financière possible dans le cadre des programmes autorisés par les Agences Régionales de Santé (ARS)*

6.3 Dispositifs médicaux, aliments diététiques destinés à des fins médicales spécialisées et appareils divers d'aide à la vie

Traitements	Situations particulières
Chambre et cathéter implantables	Chimiothérapie éventuellement à domicile
Postiche (prothèse capillaire)	Effet indésirable de la chimiothérapie - Selon besoin
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (ADDFMS) régis par l'arrêté du 20/09/2000 (liste actualisée chaque année) Dispositifs d'administration et prestations associées	Dénutrition ou risque de dénutrition (selon les critères définis à la LPP)
Dispositif de neurostimulation transcutanée	Selon besoin - Prise en charge de la douleur
Matériels de soins de support	Partie intégrante des traitements symptomatiques
Dispositifs d'aide à la vie, aliments et pansements (matériel de perfusion, d'aspiration, chambre d'inhalation, nébuliseur, matériel d'aspiration buccale et sonde, pansements et équipement nécessaire à l'hygiène, cannes et béquilles, etc.)	Selon besoin soins palliatifs, chimiothérapie à domicile

4 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=038CC05E0E8E92B2A210BDBC5C35DE52.tpdjo07v_3?idSectionTA=LEGISCTA000020892071&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20120224

7. Annexe

Professionnels de santé impliqués dans le parcours de soins : recours selon besoin pour le traitement et le suivi

Le pharmacien est un des acteurs du parcours de soins. Il intervient en articulation avec le médecin traitant pour le suivi des traitements ambulatoires. Il n'y a pas de paiement à l'acte inscrit à la nomenclature de l'assurance maladie pour cette prestation.

Actes techniques à réaliser selon les cas

Selon le programme thérapeutique, une proposition visant à préserver la fertilité féminine peut être envisagée. Il s'agit d'un acte *hors nomenclature.*

Traitements spécifiques par agents antinéoplasiques et immunomodulateurs

Suite à une autorisation temporaire d'utilisation (ATU) de cohorte depuis juin 2014 et un avis favorable de l'agence européenne des médicaments (EMA) émis le 24/07/2014, idelalisib, un inhibiteur oral de la phosphoinositide 3-kinase (PI3K) delta, a obtenu le 18/09/2014 une AMM pour le traitement de patients atteints de lymphome non hodgkinien indolent (LNHi) réfractaire après deux lignes de traitement (ayant comporté rituximab et un alkylant).

Suite à une ATU de cohorte depuis le 13/02/2014 et un avis favorable de l'EMA émis le 24/07/2014, ibrutinib, un inhibiteur oral de la tyrosine kinase de Bruton, a obtenu le 17/10/2014 une AMM pour le traitement des patients adultes atteints de lymphome à cellules du manteau en rechute ou réfractaire.

Toutes les publications de l'HAS sont téléchargeables sur

www.has-sante.fr

Toutes les publications de l'INCa sont téléchargeables sur

www.e-cancer.fr